

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ

Γενικά: Πρόκειται για αρκετά συχνό φαινόμενο, κυρίως σε ηλικιωμένους άνδρες. Μπορεί όμως σπανίως να παρατηρηθεί και σε νεότερα άτομα ιδίως μετά από νάρκωση, μετά από χορήγηση συμπαθομιμητικών και αντιχολινεργικών φαρμάκων, κατάχρηση αλκοόλ, κ.λπ. Η επίσχεση ούρων μπορεί να εκδηλώνεται με κατακράτηση ούρων ή με ακράτεια από υπερπλήρωση. Η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστεως κυμαίνεται περίπου στα 1500 ml.

Κλινική εξέταση: Εξετάζουμε αν πρόκειται για οξεία επίσχεση ούρων ή αν το πρόβλημα είναι χρόνιο με πολλαπλά επεισόδια. Η οξεία επίσχεση (με πλήρη ανουρία) προκαλεί έντονη δυσφορία και πόνο και έτσι σπανίως διαφεύγει της διάγνωσης. Για τη χρόνια επίσχεση ή την οξεία επίσχεση σε ασθενή που δε μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, μόνο από την παρατήρηση και την ενδελεχή φυσική εξέταση οδηγούμαστε στη διάγνωση (ανουρία, ψηλαφητή μάζα στο υπογάστριο, εικόνα ουρολοίμωξης, κοιλιακή διάταση με δυσκοιλιότητα).

Η διάγνωση της οξείας βακτηριακής προστατίτιδας ως αίτιο επίσχεσης, είναι σχετικά εύκολη και βασίζεται στα χαρακτηριστικά συμπτώματα (πυρετός, δυσουρία, συχνουρία, στραγγουρία, περινεϊκό άλγος, επώδυνος προστάτης στην ψηλάφηση) και συνήθως στη θετική καλλιέργεια ούρων, ενώ η διάγνωση της χρόνιας προστατίτιδας είναι δυσχερής και για τη διάγνωσή της απαιτείται εξέταση ούρων και προστατικού υγρού, με τη μέθοδο κατά Stamey-Mears.

Αιτιολογία: Υπερτροφία ή καρκίνος προστάτη, οξεία προστατίτιδα, στενώματα ουρήθρας, νοσήματα του ΚΝΣ, νόσος Parkinson, αντιχολινεργικά φάρμακα, αλκοόλ, δυσκοιλιότητα. Έχει βρεθεί ότι η οξεία επίσχεση ούρων, χωρίς την ύπαρξη σαφούς εκλυτικού παράγοντα, οδηγεί στο χειρουργείο – αργά ή γρήγορα – περίπου το 75% των ασθενών!

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Τοποθετείται προσεκτικά – με καλή αντιστηψία και ήπιους χειρισμούς – ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr και επιτρέπουμε να αποβληθούν άμεσα περίπου 300-500 ml ούρων. Στη συνέχεια διακόπτουμε τη ροή των ούρων με μια λαβίδα (για αποφυγή αιμορραγίας) και επιτρέπουμε ροή 300-500 ml, ανά 10 λεπτά. Καταγράφουμε το συνολικό ποσό ούρων.

Στην περίπτωση υπάρξεως όγκου ο οποίος προκαλεί διαλείπουσα επίσχεση ούρων, η ταχεία αποσυμπίεση της κύστης αποσυμφορίζει απότομα, τα συμπιεσμένα από καιρό μικροαγγεία της κύστης ή του όγκου με αποτέλεσμα ρήξη αυτών, με ενδοκυστική αιμορραγία κι αιματοουρία.

2. Εξετάζουμε τον προστάτη των αρρένων ασθενών με δακτυλική εξέταση. Ελέγχουμε τον αδένα προσεκτικά, με ήπιους χειρισμούς, για εκλυόμενο άλγος, διόγκωση και σκληρία.
3. Στους ασθενείς με ήδη γνωστό ιστορικό Καλοήθους Υπερτροφίας Προστάτη (ΚΥΠ) ή στους ασθενείς που δεν είναι εφικτό, στο αμέσως προσεχές διάστημα, να εξεταστούν από ουρολόγο, συστήνεται η χορήγηση ενός α-αδρενεργικού αποκλειστή (Ταμσουλοσίνη, Αλφουζοσίνη, Σιλοδοσίνη) για 15-30 ημέρες και προγραμματισμός για επανεκτίμηση.
 - ✓ tab. **Omnice/Pradif** 0,4 mg, (po) 1x1, μέχρι ο ασθενής να εξεταστεί από ειδικό ή
 - ✓ tab. **Xatral OD** 10 mg, (po) 1x1, μετά το γεύμα, για 20-30 ημέρες και επί ενδείξεων.Έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς με τιμές PSA < 3 ng/ml, με μικρό ή μέτριο προστάτη κατά τη δακτυλική εξέταση και όγκο παροχτετευθέντων ούρων μικρότερο από 1000 ml, μπορεί να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη συντηρητική θεραπεία με έναν α-αποκλειστή.
4. Χορηγείται αντιβίωση (π.χ. Κινολόνη: caps. Ciproxin 500 mg, 1x2) για 3 ημέρες.
5. Αν ο ουροκαθετήρας παραμένει πάνω από 5-7 ημέρες (που είναι σύνηθες), χορηγείται προφυλακτική αντιβίωση, π.χ. tab. Septrin 480 mg/24h. Η παραμονή καθετήρα, άνω των 3 ημερών, σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών (αιματοουρία ή ουρολοίμωξη).
6. Σε περίπτωση οξείας επίσχεσης ούρων, επί εδάφους οξείας βακτηριακής προστατίτιδας, χορηγείται αντιβίωση επί μακρόν: caps. Ciprofloxacin 500 mg, 1x2, για 4-6 εβδομάδες.
7. Σύσταση για διενέργεια U/S NOK-Προστάτη και επί ενδείξεων ή διόγκωσης του αδένος ($V_{pr} > 30-50$ cc) παραπομπή σε ουρολόγο για περαιτέρω εκτίμηση και αντιμετώπιση.